Клинические рекомендации

Мигрень

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**G43** — Мигрень **G43.0** — Мигрень без ауры [простая мигрень] **G43.1** — Мигрень с аурой [классическая мигрень] **G43.2** — Мигренозный статус **G43.3** — Осложненная мигрень **G43.8** — Другая мигрень **G43.9** — Мигрень неуточненная **G44.0** — Синдром «гистаминовой» головной боли **G44.1** — Сосудистая головная боль, не классифицированная в других рубриках **G44.4** — Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 25.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Всероссийское общество неврологов; Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"; Межрегиональная общественная организация "Российское общество по изучению головной боли"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/295_4

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 3

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 4

3.1 Критерии диагноза 4

3.2 Лекарственно-индуцированная головная боль 5

3.3 Жалобы и анамнез 6

3.4 Физикальное обследование 6

3.5 Лабораторные исследования 6

3.6 Инструментальные исследования и консультации 6

3.7 Дневник головной боли 7

3.8 Дифференциальная диагностика 7

4. Лечение 8

4.1 Купирование приступа 8
4.2 Мигренозный статус 9
4.3 Профилактическая терапия 10
4.4 Лечение мигрени с лекарственно-индуцированной головной болью 11
4.5 Немедикаментозное лечение 12
4.6 Медицинская реабилитация 12
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 13
5.1 Диспансерное наблюдение 13
5.2 Показания к госпитализации 13
6. Источник и актуальность 13
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 13

1. Основные положения

- Мигрень — первичная головная боль: приступы пульсирующей односторонней боли длительностью **4–72 часа** с повышенной чувствительностью к свету и звуку, тошнотой и/или рвотой. Обычно начинается **до 20 лет**; женщины болеют в 2,5–3 раза чаще.
- Диагноз клинический — по критериям МКГБ-3. При типичной мигрени дополнительные исследования не нужны; при редких формах ауры, осложнениях и «сигналах опасности» показаны МРТ головного мозга и МР-ангиография, консультации офтальмолога, оториноларинголога, психотерапевта.
- При мигрени со стволовой аурой наряду со зрительными, чувствительными и речевыми нарушениями возникают обратимые стволовые симптомы: дизартрия, головокружение, шум в ушах, снижение слуха, диплопия, атаксия, изменение сознания.
- Лёгкий и средний приступ купируют анальгетиками и НПВП (препарат первого выбора — ибупрофен 400 мг), тяжёлый — триптанами **в первые 30 минут** от начала боли. Профилактика показана при **3 и более** тяжёлых приступах или **8 и более** днях с болью в месяц.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Мигрень (М) — первичная форма головной боли (ГБ), проявляющаяся приступами пульсирующей односторонней боли продолжительностью **4–72 часа**, которая сопровождается повышенной чувствительностью к свету, звуку, тошнотой и/или рвотой.

Мигрень обычно возникает **до 20 лет**; в детстве чаще у мальчиков, у взрослых женщины болеют в 2,5–3 раза чаще. Максимум частоты и интенсивности приступов — в 35–45 лет, после 55–60 лет течение облегчается или приступы прекращаются.

2.2 Этиология и эпидемиология

Мигрень — хроническое нейроваскулярное заболевание с наследственной предрасположенностью. Основное звено патогенеза — периодическое периваскулярное нейрогенное воспаление сосудов твёрдой мозговой оболочки при повышенной возбудимости коры и тригеминоваскулярной системы. Механизм ауры — распространяющаяся корковая депрессия.

Распространённость мигрени в Европе и США — около 14%, в России за год — 15,9–20,8%.

2.3 Классификация

Две основные формы: мигрень без ауры — до 80% случаев, мигрень с аурой — до 20%. Реже встречаются мигрень со стволовой аурой (ранее «базилярная»), ретинальная и гемиплегическая мигрень.

Классификация мигрени (МКГБ-3, 2018)

1. мигрень без ауры;
2. мигрень с аурой: с типичной аурой, со стволовой аурой, гемиплегическая, ретинальная;
3. хроническая мигрень;
4. осложнения мигрени: мигренозный статус, персистирующая аура без инфаркта, мигренозный инфаркт, аура — триггер эпилептического припадка;
5. возможная мигрень;
6. эпизодические синдромы: синдром циклических рвот, абдоминальная мигрень, доброкачественное пароксизмальное головокружение, доброкачественный пароксизмальный тортиколлис.

2.4 Клиническая картина

Мигрень без ауры — повторяющиеся однотипные приступы интенсивной, чаще односторонней пульсирующей боли, которая усиливается при нагрузке; приступ длится **от 4 часов до 3 суток**.

1. **локализация** — преимущественно висок, глаз, темя; нередко начало в затылке
2. **сопровождающие симптомы** — тошнота, рвота, повышенная чувствительность к свету и звукам

Частота при эпизодической мигрени — от 1 дня в год до 14 дней в месяц (в среднем 2–4), при хронической — **15 и более дней в месяц**.

При мигрени с аурой фазе боли предшествуют преходящие неврологические нарушения. При типичной ауре — полностью обратимые зрительные, чувствительные и/или речевые симптомы без двигательных и стволовых; в редких случаях боль после ауры не развивается.

1. **мигрень со стволовой аурой** — два или более обратимых стволовых симптома: дизартрия, головокружение, шум в ушах, снижение слуха, диплопия, атаксия, изменение уровня сознания
2. **гемиплегическая мигрень** — чрезвычайно редкая, почти всегда наследственная; обратимые двигательные нарушения **до 72 часов**
3. **ретинальная мигрень** — обратимые односторонние зрительные феномены (вспышки, скотомы), подтверждённые исследованием полей зрения во время приступа

Наиболее частые триггеры приступа

1. стресс или расслабление после стресса, тревога, депрессия, переутомление;
2. изменения погоды;
3. менструация, овуляция, эстрогенсодержащая гормональная терапия и оральные контрацептивы;
4. голод, некоторые продукты (сыр, шоколад, орехи, копчёности, куриная печень, авокадо, цитрусовые, кофеинсодержащие продукты), алкоголь, особенно красное вино;
5. недостаток или избыток сна, духота, аэробная нагрузка, яркий или мерцающий свет, шум, пребывание на высоте.

1. **хроническая мигрень** — 15 и более дней с болью в месяц; коморбидные психические расстройства, нарушения сна, снижение эффективности средств для купирования
2. **мигренозный статус** — изнуряющий приступ **более 72 часов** с ремиссиями до 12 часов
3. **персистирующая аура без инфаркта** — симптомы ауры **более 1 недели** без признаков инфаркта мозга
4. **мигренозный инфаркт** — симптомы ауры **более 60 минут** с ишемическим повреждением, подтверждённым нейровизуализацией
5. **аура — триггер эпилептического припадка** — припадок во время приступа мигрени с аурой или **в течение 1 часа** после него

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Всем пациентам с жалобой на головную боль проводится клиническая диагностика мигрени по критериям МКГБ-3.

Диагностические критерии мигрени без ауры

1. A. Не менее 5 приступов, отвечающих критериям B–D.
2. B. Продолжительность **4–72 часа** без лечения или при его неэффективности.
3. C. Не менее 2 из 4 характеристик: односторонняя локализация; пульсирующий характер; средняя или выраженная интенсивность; усиление от обычной физической активности.
4. D. Не менее 1 симптома: тошнота и/или рвота; фотофобия и фонофобия.
5. E. Боль не соответствует лучше другому диагнозу МКГБ-3.

Диагностические критерии мигрени с аурой

1. A. Не менее 2 приступов, отвечающих критериям B и C.
2. B. Один или более полностью обратимых симптомов ауры: зрительные, сенсорные, речевые, двигательные, стволовые, ретинальные.
3. C. Не менее 3 из 6 характеристик: постепенное нарастание симптома **более 5 минут**; последовательное возникновение симптомов; каждый длится **5–60 минут**; хотя бы один симптом односторонний; хотя бы один позитивный; боль во время ауры или **в течение 60 минут** после неё.
4. D. Другой диагноз МКГБ-3 не подходит в большей степени.

Ауру не путают с продромальными симптомами за несколько часов до приступа: повышенной чувствительностью к свету, звукам и запахам, изменением аппетита, жаждой, эмоциональным возбуждением или разбитостью.

Диагностические критерии хронической мигрени

1. A. Головная боль **15 и более дней в месяц** на протяжении **3 и более месяцев**.
2. B. В анамнезе не менее 5 приступов мигрени без ауры и/или с аурой.
3. C. **8 и более дней в месяц** в течение 3 месяцев боль соответствует мигрени или купируется триптанами либо эрготамином.
4. D. Другой диагноз МКГБ-3 не подходит в большей степени.

Число дней с болью за 3 месяца устанавливают расспросом и по дневнику; важный критерий — типичные приступы эпизодической мигрени в начале заболевания.

3.2 Лекарственно-индуцированная головная боль

Частая эпизодическая (более 10 дней с болью в месяц) и хроническая мигрень могут сочетаться с лекарственным абузусом — ведущим фактором хронизации. ЛИГБ диагностируется при головной боли **более 15 дней в месяц** у пациента с первичной головной болью и регулярном злоупотреблении препаратами для купирования **более 3 месяцев**.

ЛИГБ проявляется диффузной монотонной, чаще утренней или ночной болью, нарастающей с прекращением действия препарата. Наибольший риск — у препаратов с кодеином, барбитуратами и кофеином; при выявлении ЛИГБ выставляются два диагноза.

Формы ЛИГБ по числу дней приёма

Препараты злоупотребления	Число дней с приёмом в месяц (3 месяца и более)
эрготаминсодержащие препараты, триптаны	10 и более
парацетамол, НПВП, ацетилсалициловая кислота, другие анальгетики и антипиретики	15 и более
опиоиды, анальгетики с компонентами разных классов, комбинации нескольких классов, другие препараты	10 и более

3.3 Жалобы и анамнез

Типичные жалобы

1. повторяющиеся приступы односторонней пульсирующей боли в лобно-височной или теменной области;
2. интенсивность средняя или выраженная — более 7 баллов по ВАШ;
3. продолжительность **4–72 часа**, усиление от обычной физической активности;
4. тошнота и/или рвота, повышенная чувствительность к свету и звукам;
5. при ауре — нарушения, нарастающие 5–20 минут и длящиеся **не более 60 минут**.

Характерный анамнез

1. первые приступы **до 20 лет**;
2. аналогичные головные боли у родственников;
3. урежение или прекращение приступов во время беременности и в менопаузе;
4. ухудшение при стрессе, депрессии, тревоге, злоупотреблении обезболивающими, приёме оральных контрацептивов, в преклимаксе.

У всех пациентов выявляют коморбидные нарушения — прежде всего депрессию, тревожные расстройства, нарушения сна и другие болевые синдромы: они утяжеляют течение и способствуют хронизации.

3.4 Физикальное обследование

Исследуется неврологический статус для исключения органической симптоматики; при типичной мигрени изменений нет.

Возможные находки

1. снижение настроения, тревожность;
2. вегетативные нарушения, симптом Хвостека I–III степени;
3. напряжение и болезненность перикраниальных мышц.

При менингеальных, общемозговых или очаговых знаках проводятся дополнительные исследования.

3.5 Лабораторные исследования

При типичной картине и нормальном неврологическом статусе лабораторные исследования не рекомендуются. При атипичной картине, «сигналах опасности» или осложнениях выполняются общий (клинический) анализ крови, исследования общевоспалительных реакций и коагулограмма.

3.6 Инструментальные исследования и консультации

Без атипичных черт и неврологических нарушений инструментальные исследования не рекомендуются; единичные субклинические очаги в белом веществе на МРТ маркерами мигрени не являются.

При редких формах ауры и осложнениях мигрени для исключения аневризмы, артериовенозной мальформации, диссекции сонных артерий выполняются МРТ головного мозга, МР-ангиография, МР-венография; при невозможности МРТ — КТ и КТ-ангиография.

При нетипичном течении или «сигналах опасности» — МРТ и МР-ангиография, при необходимости консультации офтальмолога, оториноларинголога, психотерапевта.

«Сигналы опасности»

1. боль, впервые возникшая после 50 лет, или изменившая течение;
2. «громоподобная» боль, нарастающая до 10 баллов по ВАШ **за 1–2 секунды**;
3. строго односторонняя боль;
4. прогрессивно ухудшающаяся боль без ремиссий;
5. внезапная, необычная для пациента боль;
6. атипичная аура: необычные нарушения и/или продолжительность **более 1 часа**;
7. изменения сознания или психические нарушения;
8. очаговые знаки и симптомы системного заболевания: лихорадка, сыпь, ригидность шейных мышц, артралгии, миалгии;
9. признаки внутричерепной гипертензии;
10. отёк диска зрительного нерва;
11. ВИЧ-инфекция, онкологическое, эндокринное, системное заболевание или травма головы в анамнезе;
12. дебют во время беременности или в послеродовом периоде;
13. неэффективность адекватного лечения.

3.7 Дневник головной боли

Дневник **в течение 1–3 месяцев** до осмотра позволяет установить характеристики приступа, число дней с болью и с приёмом обезболивающих, отличить приступ мигрени от эпизода ГБН и выявить лекарственный абузус.

3.8 Дифференциальная диагностика

Чаще всего мигрень дифференцируют с ГБН, кластерной головной болью, хронической пароксизмальной гемикранией и цервикогенной головной болью.

Мигренеподобная боль возможна при

1. транзиторной ишемической атаке и инсульте;
2. гигантоклеточном артериите;
3. диссекции артерий, аневризмах, артериовенозных мальформациях;
4. церебральном венозном тромбозе;
5. опухоли головного мозга;
6. субарахноидальном кровоизлиянии;
7. антифосфолипидном синдроме и тромбофилиях;
8. эпилепсии;
9. синдромах MELAS и CADASIL.

Эти заболевания всегда проявляются неврологическим дефицитом или другими «сигналами опасности». Сочетающиеся формы головной боли вносятся в диагноз.

Для ауры типично постепенное нарастание симптомов на одной стороне тела за 10–30 (до 60) минут — «марш» со сменой позитивных и негативных симптомов.

1. зрительные феномены: мерцание, зигзаги, тёмные пятна, скотомы;
2. затем парестезии и онемение от кисти к плечу и лицу;
3. далее речевые расстройства;
4. в конце ауры — мигренозная боль.

При ТИА нарушения негативные и возникают остро и одновременно; боль не характерна, мигрени в анамнезе, как правило, нет.

Хроническую мигрень дифференцируют с хронической ГБН, новой ежедневной персистирующей головной болью и гемикранией континуа; опираются на ранний анамнез — типичные приступы эпизодической мигрени, наследственность, мигренозные триггеры, облегчение во время беременности.

Мигрень плохо диагностируется: вместо неё ставят дисциркуляторную энцефалопатию, остеохондроз шейного отдела, вегетососудистую дистонию, цервикогенную головную боль, боль при артериальной гипертензии — из-за трактовки неспецифических изменений УЗДГ и рентгенографии как органических. Неверный диагноз ведёт к назначению психостимуляторов и ноотропов, которые способствуют хронизации.

4. Лечение

Лечение включает три подхода: поведенческую терапию, купирование приступов и профилактическое лечение. Цели — уменьшение частоты и тяжести приступов и числа принимаемых обезболивающих, коррекция коморбидных нарушений, профилактика хронизации.

Поведенческая терапия

1. разъяснение доброкачественной природы мигрени;
2. обоснование нецелесообразности дополнительных исследований;
3. роль провокаторов приступов и необходимость их избегать;
4. факторы хронизации: стресс, лекарственный абузус, коморбидные нарушения;
5. цели лечения и действие профилактических препаратов;
6. при злоупотреблении обезболивающими — временный отказ от них и строгий контроль их числа.

4.1 Купирование приступа

1. **лёгкий приступ** — пациент способен выполнять привычную домашнюю и профессиональную работу
2. **приступ средней тяжести** — эти виды деятельности существенно ограничены
3. **тяжёлый приступ** — необходим постельный режим

Терапию назначают в зависимости от тяжести приступа и степени дезадаптации.

Купирование лёгкого и среднего приступа

Препарат	Разовая доза	УУР
ацетилсалициловая кислота — препарат выбора	1000 мг внутрь	A
ибупрофен — препарат выбора	400 мг внутрь	A
напроксен — препарат выбора	500 мг внутрь	C
парацетамол — препарат выбора	1000 мг внутрь	A
диклофенак — препарат выбора, порошок для раствора внутрь	50 мг	A
кетопрофен	75 или 150 мг внутрь	B
ацетилсалициловая кислота + кофеин + парацетамол	2 таблетки внутрь	B

Принципы применения анальгетиков и НПВП

1. НПВП и ацетилсалициловая кислота эффективнее парацетамола;
2. препарат первого выбора — ибупрофен 400 мг: наименьший риск желудочно-кишечных осложнений;
3. для контроля приёма ведётся дневник;
4. учитывают действие НПВП на ЖКТ и риск кровотечений;
5. не рекомендуются метамизол натрия (агранулоцитоз), опиоиды, препараты с кодеином или барбитуратами (абузус и ЛИГБ);
6. быстрорастворимые формы действуют быстрее: кетопрофен (лизиновая соль) 40 или 80 мг, диклофенак 50 мг в порошке.

При тошноте и рвоте вместе с анальгетиком применяют противорвотные средства: они уменьшают гастростаз и улучшают всасывание обезболивающих.

1. метоклопрамид: 10 мг внутримышечно или 10–20 мг внутрь
2. домперидон: 10 мг 3 раза в сутки внутрь

При тяжёлых приступах и неэффективности анальгетиков и НПВП применяют триптаны; они наиболее эффективны и могут применяться и при приступах средней тяжести.

Триптаны для купирования приступа

Триптан	Разовая доза
суматриптан	50 или 100 мг внутрь
элетриптан	40 или 80 мг внутрь
золмитриптан	2,5 или 5 мг внутрь или назальный спрей
ризатриптан	10 мг внутрь или диспергируемые в полости рта таблетки

Правила приёма триптанов

1. в самом начале приступа — **в первые 30 минут** от начала боли;
2. не меньше суматриптан 50 мг, элетриптан 40 мг, золмитриптан 2,5 мг, ризатриптан 10 мг;
3. при мигрени с аурой — не во время ауры, а в конце её или в начале фазы боли;
4. не более **10 дней в месяц**; повторная доза — **через 2 часа**, не более 2 доз в сутки;
5. при неэффективности одного триптана пробуют другие.

Противопоказания: ишемическая болезнь сердца, окклюзионные заболевания периферических сосудов, неконтролируемая артериальная гипертензия, мигрень со стволовой аурой.

Наиболее безопасен при сердечно-сосудистом риске элетриптан; назальный спрей золмитриптана начинает действовать **через 15 минут** и предпочтителен при выраженной тошноте и рвоте.

При тяжёлом приступе, особенно при невозможности приёма внутрь из-за тошноты и рвоты, применяется #кеторолак 60 мг внутримышечно или 30 мг внутривенно.

4.2 Мигренозный статус

При мигренозном статусе применяют триптаны, если пациент не принимал их для купирования приступа.

В стационаре статус купируют парентеральным введением препаратов, выбор которых определяется картиной и тяжестью; лечение проводится в тихом затемнённом помещении.

Купирование мигренозного статуса

Препарат	Разовая доза и путь введения
метоклопрамид	10 мг внутривенно капельно в 50 мл раствора натрия хлорида за 20 минут
#хлорпромазин	0,1 мг/кг внутривенно капельно

Препарат	Разовая доза и путь введения
#декскетопрофен	50 мг внутривенно
#кеторолак	60 мг внутримышечно или 30 мг внутривенно
#магния сульфат — только при статусе мигренозной ауры	2 г внутривенно капельно
#вальпроевая кислота — не у женщин детородного возраста	800–1000 мг внутривенно
#дексаметазон — для предотвращения возврата приступа	10–24 мг внутривенно

Внутривенное введение дроперидола и галоперидола не рекомендуется из-за риска побочных реакций. Перед назначением антипсихотических средств выполняется ЭКГ (удлинённый QT — противопоказание). Парентеральное введение жидкостей показано только при повторной рвоте и дегидратации.

4.3 Профилактическая терапия

Профилактика показана при **3 и более** тяжёлых дезадаптирующих приступах в месяц при адекватном купировании или **8 и более днях** с болью в месяц, а также при пролонгированной ауре даже при редких приступах.

Другие показания

1. неэффективность или плохая переносимость средств купирования;
2. хроническая мигрень;
3. лекарственный абузус, ЛИГБ;
4. мигренозный инфаркт или статус в анамнезе, мигрень со стволовой аурой, гемиплегическая мигрень;
5. тяжёлые коморбидные нарушения;
6. предпочтение пациента.

Принципы профилактического лечения

1. начинать с монотерапии препаратом с доказанной эффективностью, медленно повышая дозу;
2. оценивать эффект **через 3 месяца**: эффективно, если число дней с болью снизилось **на 50% и более**; ботулинотерапию — не ранее чем через 6 месяцев;
3. при эффекте — продолжать **6–12 месяцев**, затем постепенная отмена;
4. избегать избыточного приёма средств купирования (чаще 2 дней в неделю);
5. учитывать коморбидные заболевания;
6. длительность — **6 месяцев** при эпизодической и **12 месяцев** при хронической мигрени.

Препараты для профилактики мигрени

Препарат	Суточная доза	УУР
метопролол — первый выбор	100–200 мг внутрь	B
пропранолол — первый выбор	80–160 мг внутрь	A

Препарат	Суточная доза	УУР
топирамат — первый выбор; титрация с 25 мг, основная доза вечером, курс до 12 месяцев	100 мг, возможно до 200 мг	B
ботулинический токсин типа А — первый выбор, только при хронической мигрени	155–195 ЕД по протоколу PREEMPT каждые 12 недель	A
фреманезумаб, эренумаб — первый выбор при 4 и более днях с болью в месяц	фреманезумаб 225 мг подкожно ежемесячно или 675 мг раз в 3 месяца; эренумаб 70 или 140 мг подкожно ежемесячно	A
#атенолол — второй выбор	100 мг	B
#амитриптилин, #венлафаксин — второй выбор	50–150 мг; 75–150 мг	B
#кандесартан — второй выбор	16 мг	B
#вальпроевая кислота — второй выбор, нежелательна у женщин с детородным потенциалом	400–1500 мг внутрь	A

Моноклональные антитела к CGRP назначают **от 6 до 12 месяцев** и более, эффективность оценивают **через 3 месяца**; при хронической мигрени курс продлевают до 18 месяцев. Ботулотоксин вводят в 7 групп мышц головы и шеи; эффект одной процедуры сохраняется около 3 месяцев.

4.4 Лечение мигрени с лекарственно-индуцированной головной болью

Частая эпизодическая мигрень (8 и более дней с болью и 8–10 дней с приёмом обезболивающих в месяц) — группа риска ЛИГБ: пациентам разъясняют безопасный режим — **не чаще 2 дней в неделю, не более 8 дней в месяц**.

Для обратной трансформации хронической мигрени в эпизодическую препарат, вызвавший ЛИГБ, отменяют полностью или частично: приём обезболивающих — **не более 2 дней в неделю (8 в месяц)**.

1. **амбулаторно** — отмена анальгетиков, антипиретиков и триптанов
2. **в стационаре или дневном стационаре** — отмена опиоидов, спазмолитиков, психотропных препаратов и анальгетиков в комбинации

В период отмены лечат «рикошетную» боль и другие симптомы отмены; препараты первого выбора — кортикостероиды системного действия, НПВП, противорвотные и анксиолитики.

1. #преднизолон: 100 мг 5 дней или 60 мг с постепенным снижением на 5–10 мг каждые 3 дня в течение 1–2 недель
2. #метилпреднизолон: 500 мг внутривенно или 125 мг в 250 мл раствора натрия хлорида с #диазепамом 10 мг и эзомепразолом 40 мг внутривенно капельно 1 раз в сутки 5 дней
3. #дексаметазон: 8 мг внутривенно капельно 1 раз в сутки 5 дней
4. #целекоксиб: 400 мг в сутки внутрь 5 дней, затем снижение на 100 мг каждые 5 дней
5. метоклопрамид при рвоте: 10 мг 1 раз в сутки внутрь или внутримышечно 5–7 дней

Детоксикацию проводят **в первые 2 недели** отмены; можно применять препараты тех классов, которыми пациент не злоупотреблял. С кортикостероидами и НПВП добавляют ингибиторы протонного насоса.

Для профилактики частой эпизодической и хронической мигрени с ЛИГБ применяют топирамат (100 мг/сут, диапазон 50–200 мг, титрация с 25 мг по 25 мг в неделю), ботулинический токсин типа А (155–195 ЕД по протоколу PREEMPT) и моноклональные антитела к CGRP; профилактику предпочтительно начинать одновременно с отменой.

4.5 Немедикаментозное лечение

Фармакологическое лечение сочетают с немедикаментозными методами для повышения эффективности терапии.

При тревожно-депрессивных и соматоформных расстройствах — когнитивно-поведенческая терапия, психотерапия и психологическая релаксация (УУР А).

Биологическая обратная связь по частоте пульса и электромиографии мышц скальпа и шеи — обучение психологическому и мышечному расслаблению (УУР А).

Рефлексотерапия (акупунктура) — дополнительный метод профилактического лечения (УУР В).

Постизометрическая релаксация — при выраженной дисфункции перикраниальных мышц (УУР А).

Лечебная физкультура (УУР В): упражнения лёгкой интенсивности, тренировки на выносливость, скандинавская ходьба — **максимум 3–4 раза в неделю** по 20–60 минут.

Блокада большого затылочного нерва кортикостероидами и местными анестетиками — дополнительный метод (УУР С).

Высокочастотная ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция — дополнительный метод профилактики, в том числе при хронической мигрени (УУР В).

Неинвазивная электростимуляция первой ветви тройничного нерва — для купирования приступов и профилактики (УУР А).

Инвазивная нейростимуляция большого затылочного нерва — при рефрактерной хронической мигрени; направление — совместно специалистом по головной боли и нейрохирургом (УУР А).

Диетотерапия не рекомендуется; целесообразен совет исключить продукты-провокаторы: шоколад, бананы, орехи, цитрусовые, жирные сыры, алкоголь.

4.6 Медицинская реабилитация

Реабилитация направлена на улучшение функционирования и качества жизни.

1. постизометрическая релаксация, лечебная физкультура, дыхательные упражнения;
2. массаж шеи, воротниковой зоны и спины;
3. рефлексотерапия;
4. коррекция осанки, эргономика рабочего места.

Профилактика эффективна, если число дней с болью **через 3 месяца** сокращается **на 50% и более**.

Дополнительно оценивают приём обезболивающих, коморбидные нарушения и работоспособность. Без улучшения, а также при тяжёлом течении (хроническая мигрень, множественные коморбидные нарушения, ЛИГБ) пациента направляют в специализированный центр лечения головной боли.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Всем пациентам показано динамическое наблюдение, в том числе с телефонными визитами.

1. разъяснение роли триггеров;
2. разъяснение факторов хронизации: стресса, депрессии, лекарственного абузуса, избытка кофеина, ожирения, синдрома апноэ во сне;
3. контроль эффективности и переносимости профилактики.

5.2 Показания к госпитализации

Экстренная госпитализация в неврологическое отделение

1. головная боль с изменением сознания;
2. с лихорадкой и менингеальными симптомами;
3. с нарастающей очаговой неврологической симптоматикой;
4. с нарастающей общемозговой симптоматикой;
5. «громоподобная» головная боль;
6. мигренозный статус.

Плановая госпитализация

1. прогрессирующая головная боль;
2. некупируемая головная боль;
3. тяжёлая ЛИГБ при злоупотреблении опиоидами, спазмолитиками, психотропными препаратами и анальгетиками в комбинации;
4. атипичная аура **более 1 часа**.

Критерии выписки

1. купирование головной боли;
2. уменьшение боли **до 3–4 баллов по ВАШ**;
3. успешная замена препарата злоупотребления на адекватную терапию.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Мигрень»
Версия	4-я, опубликована в рубрикаторе 25.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	295_4 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Всероссийское общество неврологов; Российское общество по изучению головной боли; Союз реабилитологов России
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации при сверке не выявлено.